

## Informe Psicológico

### **I. IDENTIFICACIÓN**

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Nombre              | : Máximo Zúñiga Castro            |
| Fecha de nacimiento | : 4 de Febrero de 2014            |
| Edad                | : 8 años, 4 meses                 |
| Colegio             | : Bicentenario College La Florida |
| Evaluada            | : Ps Celeste Cádiz                |
| Fecha de informe    | : 13 de Junio de 2022             |

### **II. MOTIVO DE CONSULTA**

Madre solicita apoyo psicológico de reparación y contención para Máximo por eventos ocurridos en su establecimiento educacional.

### **III. ANTECEDENTES RELEVANTES**

Máximo tiene 8 años y vive junto a su madre y abuela en la comuna de La Florida. A raíz del confinamiento por pandemia es que Máximo inicia sus clases en Bicentenario College, colegio con Programa de Integración Escolar (PIE), en modalidad remota hasta en marzo de 2022 donde cursa presencialmente sus clases. Máximo se acoge al programa PIE dado su diagnóstico TEA, nivel 1.

En antecedentes clínicos relevantes es relevante mencionar que Máximo fue diagnosticado por Trastorno del Espectro Autista por neurología.

Finalmente, a nivel conductual es pertinente mencionar que Máximo ha manifestado cambios considerables desde dos hechos en particular que ocurren en su colegio en particular con su profesora “Pamela” donde el menor relata que la docente lo empuja y daña por la consecuente caída contra el suelo de cemento. Asimismo, Máximo manifiesta varios relatos en torno a lugares y personas del colegio que le causan miedo, así como compañeros que se encuentra en el patio en horario de clases. Manifiesta un



rechazo alto a situaciones que pudieran desafiar su tolerancia, hipervigilancia y miedos hacia el exterior y personas desconocidas.

Cabe destacar que Máximo ha manifestado angustiado ciertos relatos, que en ocasiones desencadenan crisis, el contenido está asociado en su mayoría al que debe guardar un “secreto” en reiteradas ocasiones en una misma sesión y en el proceso mismo en general, así como que le darán dinero el cual debe guardar en el “banco del pato”, que debe salvar “al niño chascón de los ladrones en el baño”, acompañados de activación motora y reprocharse a sí mismo cuando menciona algún tipo de relato.

En el último tiempo Máximo ha manifestado tener temor que le hagan daño a su madre por lo que ha mantenido un vínculo adhesivo y ansiedad de separación por esta misma razón, dado que ante la mínima distancia aparece sintomatología ansiosa, crisis de angustia y se mantiene hiperalerta.

#### **IV. OBSERVACIÓN CLÍNICA Y CONDUCTA**

Máximo se muestra participativo, colaborador y propositivo la mayor parte del tiempo con la terapeuta. Se observa presencia de intención comunicativa y atención conjunta incorpora constantemente a la terapeuta en el juego, el cual es predominantemente simbólico. Su nivel atencional varía de acuerdo a sus intereses y motivación, logrando estar focalizado y concluir aquellas propuestas que son de su total agrado, a diferencia de aquellas donde no hay mayor interés la pospone.

Asimismo, el menor se muestra muy interesado en llevar a cabo el juego con otros, los incorpora activamente en el juego, en ocasiones le dificulta incorporar límites y normas del contexto, cuando se acompaña en ello, la internalización es mayor.

Finalmente, manifiesta gran interés por ser escuchado, contenido y validado, a medida que avanza el proceso de evaluación, disminuye sus niveles de ansiedad, y se observa adherencia al proceso terapéutico y a la terapeuta.

## **V. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

En base a la información obtenida de la evaluación se aprecia que Máximo es un niño entusiasta, activo, colaborador y propositivo. Mantiene conexión constante con el mundo inmediato, se observa sensibilidad y apertura al ambiente.

Asimismo, se observan indicadores ansiedad y control interno a partir de juego simbólico y externalización que en su mayoría logran ser eficaces frente a situaciones de estrés o frustraciones a excepción en situaciones donde ocurre un cambio de personas o situaciones de referencia, su adaptación se ve interferida por lo que la frustración no logra ser canalizada como de costumbre. En ocasiones su tolerancia a la frustración aparece cuando no logra darse a entender o comunicar sus necesidades como él desea. Además, se observa dificultades con internalización y actuación de normas sociales contextuales del centro de terapia, como de otros pacientes, terapeutas o padres en la sala de espera. También es posible identificar patrones estructurados, profundos y definidos sobre ciertas temáticas, acompañado de indicadores de flexibilidad cognitiva baja que gatillan crisis descompensatorias. En torno a la comprensión del lenguaje es adecuado de acuerdo a su edad, suele verse se interferida cuando se presenta lenguaje figurado o frases que no sean estrictamente literales. Si bien existe una intención comunicativa, presenta habilidades sociales restringidas, en especial aquellas que hablan de la inclusión grupal e internalización de normas sociales.

Con respecto a su autoestima y autoconcepto se manifiesta con valoración disminuida sobre sí mismo en torno por comparación que realiza con otros, desconfianza, así como la necesidad de validación y dependencia de sus cercanos para cumplir sus objetivos. Asimismo, manifiesta atención conjunta y disfrute compartido cuando son actividades de su gusto, la mayor parte del tiempo se mantiene hiperalerta de su entorno.

En relación a su familia, Máximo la percibe como su núcleo de afectos, presenta un apego y vínculo adhesivo con su madre, asociada a una ansiedad de separación con tendencia a la dependencia emocional. Manifiesta sentirse seguro y tranquilo mientras estén en su hogar con su familia.

En cuanto a la dinámica familiar, se puede observar que su madre está enfocada en atender las necesidades de Máximo, logrando brindar apoyo y contención cuando lo requiere. Se observa en Máximo un nivel de respuesta adecuado a las demandas, comprende y responde ante solicitudes y ordenes cuando se encuentra seguro, ya que la inseguridad o cambio de contexto pueden resultar descompensándolo dada su situación actual post traumática. Se observan habilidades parentales altas, principalmente mentalización, refuerzo positivo, validación de emociones y protección.

Cabe destacar la exposición y experiencia directa de los sucesos traumáticos, así como presenciar de manera directa sucesos ocurrido a otros. Lo anterior acompañado de síntomas intrusivos como recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos de los sucesos traumáticos, reacciones disociativas en las que el menor actúa como si se repitieran los episodios traumáticos, malestar psicológico intenso y prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto de los sucesos traumáticos. Asimismo esfuerzo y evitación constante de recordar estímulos asociados al suceso traumático sean estos sean internos y externos. Así como también, presencia de alteraciones cognitivas y del estado de ánimo manifiestas en expectativas negativas persistentes y exageradas sobre sí mismo, los demás o el entorno, acusación hacia sí mismo por percepción distorsionada persistente de la causa o las consecuencias de los episodios, estado emocional negativo persistente en forma de miedo, terror, enfado, culpa y vergüenza y disminución importante del interés o la participación en actividades que antes le eran significativas. Por último, alteración importante de la alerta y reactividad tras los episodios traumáticos como comportamiento irritable y arrebatos de furia, hipervigilancia, respuesta de sobresalto exagerada y problemas de concentración. Todo lo anteriormente mencionado supera el mes desde su presentación de síntomas, así como es causante de un malestar clínicamente significativo y cuyo origen no remiten a efectos de sustancias u otra afección médica.

En conclusión, del proceso de evaluación se desprenden indicadores relevantes que coinciden con el diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista que está alineada con el



diagnóstico realizado por su neurólogo tratante. El nivel pesquisado corresponde a TEA, nivel 1, es decir, requiere ayuda solo en algunos contextos, de apoyo facilitador parcial e intermitente. En segundo lugar, a la luz de los resultados es posible evidenciar Trastorno por Estrés Postraumático, tanto por los relatos como por la manifestación de síntomas que implican significativamente su calidad de vida.

**Celeste Cádiz Quezada**  
**Psicóloga Clínica Infanto-Juvenil**  
**Reg. MINEDUC 311415**